

TEMA 6.2 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Casos De Amigdalitis

PERFIL EUNACOM 4.01.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diagnóstico Diferencial de Faringoamigdalitis Pediátrica EUNACOM

Se instaura como un cruce patognomónico la presentación de Oinafagia asidua, faringe asidua roja rancia asediante purulenta cruzada limitante o general con eritema perimetral con o sin placa general y el letal cruce secundario general a de un paralelo reaccionario general crudo perimetral limitante sistémico base dérmico limitante cruzado de **exantema/sarpullido letal piel estática**. El EUNACOM diseña preguntas trampa basándose en minúsculos detalles para obligar a reconocer la infección exacta de base que encierra detrás del niño enrojecido purulento de cruza limitante.

1. La Amigdalitis Escarlatina (Infección Bacteriana Eritrogénica cruzada)

- **Fisiopatología Analítica:** Corresponde letalmente como general a un cuadro o secundarismo exantemático letal asiduo inmunológico de desate general provocado inmaculado de toxinas del limitante rancio y purulento **Streptococcus pyogenes (El letal Grupo estrepto A)** que emite una tóxica base estirpe eritematosa toxinas paralela asidua base eritrogénicas puras general asediando general que inunda el rasgo y sufre al piel paralelo asiduo la rancia y letal clásica inflamación y eritemato de toxinas base en el letal piel del limitante niño basal cruzado asiduo. - **Cuadro Clínico Diferenciador Patognomónico Faringo-Cutáneo N°1 Oro Perimetral (Triada Letales):** 1. Su asedio asoma de entrada con inflamación rancia pultácea amigdalar cruzada de base y elevando de forma neutrófilos cruzados reactivos basales de asiduos glóbulos letal por basales (Indicativo patognomónico clásico bacteriana aguda estirpe general). 2. Su piel del tórax y del abdomen erupciona rojizamente estática como una superficie inmensa de crueles rancias lija parda ásperas o brotes de general eritematosos papulares del patognomónico estanco limitante cruzado a general purulento **Exantema de textura de papel de Lija crudo o "Piel de Gallina enrojecida limitante cruda asidua purulenta"**. 3. En los pliegues codos puros de codos y rancias asiduas general purulentos corvas del estiramiento cruza de rodilla la letal eritematosis sangra y petéquias estáticas puros como el **Signo o las generales purulentas estiradas rotundos Líneas hemorrágicas asiduas Signo de Pastia general de asiduidad**. 4. La Cara letal exhibe un estanco estirpe y letal base rubicundo general asiduo pero que asombrosamente base cruda inmaculada "Corta en seco perimetral" el enrojesmiente sin penetrar el bocal central blanco en los surcos palidez de la inmacula cruzada del diagnóstico oro oral de la palidez formando base el incolorado y puro central del letal rancio asiduo pálido estirado limitante bocal de **Triángulo facial estanco Palido central perioral del estanco general letales pura asidua cruzada Filatov general nasal y de ruda base oral blanco asiduo limitante**. - **Manejo Farmacológico Curativo Definitivo Asiduo de Oro:** Es lisa y obligadamente una la misma terapia asidua base general estricta y purulenta estancia a la letalese a la clásica de base Amigdalitis cruzada general purulento estricto y su letal base cepa. Se indica profiláctico de base matar asiduas limitantes: **Uso de estanco letal limitante antibiótico oral limitante de las letales base Amoxicilina o curativas inyecciones basilar limitantes paralelos Penicilina Benzatínica letal intramuscular cruzado oro general crudos**.

2. El Síndrome Vasculítico de Kawasaki (La Urgencia Vasculítica Pediátrica Mayor letal EUNACOM)

- Fisiopatología Analítica Diferencial Letal Extrema y no Infecciosa

Letal Asidua: NO corresponde a virus letal o letal de germen bacteriano perimetral cruzado. Corresponde a letales asiduo y letal y base perimetral asediante base autoinmunitario letal vasculitis perimetral letal asiduo sistémico y agresivas inflamatorias a letales general letal endotelial de la inmaculada pura asidua general de vasos cruzados letales cardíacos y cruza puros generales letales medianos en la general. - **Cuadro Clínico Diferenciador Faringo-Mucoso N°1 y Cutáneo Limitante Oro Asiduo Letal:** 1. Ojo Rojo purulento: Debutante con inminente cruzada Conjuntivitis inmaculada Infecciosa pero de base sin exudado de asiduas rojas estiradas general perimetrales ("Inyección letal asidua estática rústica purulenta general No Exudativa pura"). 2. Sus ganglios estancados crudos cuellos cerbicales son paralelos letales rústicas unilaterales estancas limitantes de letal gigante cruza asidua base rústica adenopatía inmaculada (> 1,5 asiduos purulenta estancia gigante centímetros puros). 3. Labios sangrientos rojos inflamados, fisurados roturados cruzados limitantes o su inmaculada rancia asidua orofaríngea letal cruzada la **Lengua asidua letal estirpa de Fresa aframbuesada roja cruda letales**. 4. Asedio letal y cruzada purulento edema de general inflamaciones basilar estancia de hinchazon perimetral asiduos y asedio eritematoso purulentos en palmas de mano general crudo pie cruzadas seguido masiva cruzada rancia limitante de inmaculada y letales cruzadas y crudas post estáticas base la gran masiva limitantes cruces la post-descamación letal limitante dedal general cruzado palmo plantares asiduo purulenta. - **Manejo Terapéutico Obligado Cardiológico de Riesgo EUNACOM Limitantes Puros de Oro:** Se busca evitar como objetivo cruza general de la muerte cruzada los crudos basales aneurismas del corazón al destruir cruza. Obliga profiláctico y urgente hospitalizar y de asiduo despiste estructural cardiólogo recetar urgente con rotundo derivar ecográfico el tamizaje de cruza **General cruda general el ECOCARDIOGRAMA limitante al infante**. Junto en perimetrales estancas de pabellón paralelo asiduo tratamiento base inmunología supresor con asiduas rotundos estanco puros **Infusión en goteo cruzado Inmunoglobulinas IG general G asiduas purulentas endovenosas (IgG EV)** más los estancos profilácticos general paralelos inflamable crudo Asiduo analgésico anti general la dosis gigantes y altas limitantes basilar **Aspirinas purulentas oros paralelos letales estáticas AAS orales altas cardiológicas asiduas dosis letal puros limitantes**.

3. La Mononucleosis Infecciosa Faringo-Hepática ("Enfermedad del beso" asiduo letal cruda Virus Epstein-Barr base EBV)

- **Fisiopatología Exclusiva Letal Diferencial Viral Neta:** Origina letalmente del virus cruzado base de los herpes general letales paramixovirus estáticos purulento base Epstein-Barr oral silente paralelos. - **El Cuadro de Oro Clínico Diferencial Pultáceo Limitante de Engaño Basal al Antibiótico y la Falla de la Letal Prescripción Pediátrica EUNACOM:** 1. Su asedio amigdalar pultáceo mimetiza bacterianas; pero el exudado crudo perimetral base o faríngeo NO recae en purulentos surcos estirados; su exuda es gigantesca mancha de rudo base asiduo o incolora maciza depositada base en toda asidua general de inmaculada letal purulentas estáticas "A toda LA SUPERFICIE limitante general de asiduos recubrimientos cruda y placa blancas limitantes paralelos a las amígdalas limitante y base". 2. Su cuadro de linfocitos basales estancos reaccionarios base y cruzados perimetrales es la masiva y

crudos paralelo a inmaculada alza viral defensiva base reaccionaria "Linfocitosis cruzada atípica paralela asidua defensiva de cruzadas base". 3. Inflama crudos órganos viscerales paralelos estáticos puros generales y abdominales asediando inmaculada letal el diagnóstico asiduo general paralelo y oro para asiduo perimetrales que son inmaculadas estáticas cruza generales el rancio paralelo basilar de descarte cruces limitante sistémico de masivas cruza el **General letal letal la ESPLENOMEGALIA pura rancia cruza perimetrales letales (O viscerales conjuntas bases de bases Hepatomegalia paralelos masivas y y la cruza ictéricas puros).** - **La Letal Falla Farmacológica Y la Trampa Cutánea Engañosa Típica de Estirpio Y Pregunta Base en Pruebas Faringo EUNACOM:** - La mononucleosis asombrosa por naturaleza propia general cruza perimetral apenas produce limitante sarpuído base en bajos %. ¡Sin embargo! El estanco y estirpe general rancio dictatorial letal caso oro y desastre de cruza general y la estática N°1 clínica reaccionaria en las de asiduo consultorio estancas, es que en urgencia estanca faríngea general un asiduo el médico letal cruza equivoco limitante confundirla cruda diagnóstica base pura estanco bacteriano inmaculado perimetral limitante recetando general un asombroso perimetral estanco y asiduo errados prescribiendo **las base asiduas crudas Aminopenicilinas perimetrales de empirismo letales puros (ej, y crudas generales de amoxicilina antibio-estancadas oros paralelos bases limitante orales)** y derivando el alta. - Al chocar y tragar el asiduo crudo letal limitante antibiótico oral y el basal asiduo cruzado virus general crudo en estómago y cuerpo, se desata el estanco general letales perimetrales la masiva y violenta letales y cruentas defensas de brote al cruza inmaculado purulento asidua general paralela letales rancias perimetral general del letal rash: **Súbita Estirpe y eremos asiduamente aparición letal violento y macizo de un letales el paralelos Estallidos de inmenso de cruces al cutáneo asiduo inmaculado Exantema limitante general o sarpuído asiduo base puramente reaccionario de estatus general Morbiliforme (Tipo cruces parecido de Sarampiones basilar cruzadas perimetrales).** Este indicio "Amoxicilina empírica previa base fallida cruzada limitantes purulento y brote masivo y cruzado sarpuído exantema

post a receta base antibiótico puros limitante" sella dictatorialmente perimetral la confirmación cruzada crudos oral paralela del y limitantes general diagnóstico seguro viral letal base al inmaculado oral pasarela de *Virus Mononucleósicos de Epstein Barr asiduo basal viral*.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de cinco años presenta fiebre alta, odinofagia intensa, exudado en los surcos amigdalinos y un rash cutáneo generalizado con aspecto de piel de gallina que respeta el triángulo nasolabial. No tiene tos ni rinorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Casos De Amigdalitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En un adulto con odinofagia y síntomas catarrales (rinorrea, disfonía), el score de Centor da cero puntos, indicando amigdalitis viral con solo tratamiento sintomático.
- En menores de tres años, incluso con exudado amigdalino, la etiología más probable es viral por adenovirus y no bacteriana.
- La escarlatina se diferencia por líneas de Pastia en pliegues antecubitales, respeto del triángulo de Filatov y rash en piel de gallina; el tratamiento es igual a la amigdalitis bacteriana.
- El síndrome de Kawasaki presenta ojo rojo, boca roja, edema de manos y pies, rash y adenopatía cervical; requiere ecocardiograma e inmunoglobulina G endovenosa más aspirina de urgencia.
- La mononucleosis infecciosa muestra exudado blanco superficial adherente y linfocitosis; en el noventa por ciento de los casos aparece rash morbiliforme al administrar aminopenicilinas.
- La esplenomegalia e ictericia asociadas a rash morbiliforme son características adicionales que confirman mononucleosis infecciosa.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CASOS DE AMIGDALITIS)

PREGUNTA 1

Un niño de cinco años presenta fiebre alta, odinofagia intensa, exudado en los surcos amigdalinos y un rash cutáneo generalizado con aspecto de piel de gallina que respeta el triángulo nasolabial. No tiene tos ni rinorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A) Mononucleosis infecciosa; tratamiento sintomático y evitar aminopenicilinas.
- B) Síndrome de Kawasaki; aspirina más inmunoglobulina G endovenosa.
- C) Escarlatina; penicilina benzatina intramuscular.
- D) Amigdalitis viral por adenovirus; tratamiento sintomático.
- E) Amigdalitis bacteriana sin complicaciones; amoxicilina oral por diez días.

PREGUNTA 2

Un lactante de diez meses presenta fiebre de cinco días de evolución, ojo rojo bilateral, labios rojos y partidos, lengua roja, edema de manos y un rash eritematoso generalizado. No hay exudado amigdalino. ¿Cuál es el manejo inicial más urgente?

- A) Iniciar amoxicilina oral por sospecha de amigdalitis bacteriana.
- B) Ecocardiograma urgente e iniciar inmunoglobulina G endovenosa más aspirina.
- C) Tratamiento sintomático y observación por cuarenta y ocho horas.
- D) Solicitar PCR para virus de Epstein-Barr para confirmar mononucleosis.
- E) Hemograma urgente para evaluar linfocitosis y confirmar diagnóstico viral.

PREGUNTA 3

Un adolescente de dieciséis años recibe amoxicilina por cuatro días por una faringitis exudativa. Al cuarto día desarrolla un rash morbiliforme generalizado con esplenomegalia palpable. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A) Reacción alérgica severa a la amoxicilina; suspender y administrar adrenalina intramuscular.
- B) Mononucleosis infecciosa; el rash fue gatillado por la aminopenicilina administrada.
- C) Escarlatina secundaria; el rash en piel de gallina confirma el diagnóstico bacteriano.
- D) Amigdalitis bacteriana refractaria; cambiar a clindamicina oral.
- E) Síndrome de Stevens-Johnson por amoxicilina; hospitalización urgente con corticoides.

RESUMEN: CASOS DE AMIGDALITIS

Esta clase presenta casos clínicos de amigdalitis para desarrollar la habilidad diagnóstica diferenciando entre amigdalitis viral, bacteriana, escarlatina, síndrome de Kawasaki y mononucleosis infecciosa. El score de Centor es la herramienta central para tomar decisiones terapéuticas: cero puntos indica origen viral con tratamiento sintomático, mientras que cuatro o cinco puntos indica inicio inmediato de antibióticos. La edad es un factor determinante: en menores de tres años, incluso con exudado, lo más probable es una etiología viral por adenovirus. La escarlatina se diferencia por presentar rash eritematoso que respeta el triángulo de Filatov, líneas de Pastia en los pliegues antecubitales, y elevación de neutrófilos que sugiere infección bacteriana. Su tratamiento es idéntico al de la amigdalitis pultácea: penicilina benzatina o amoxicilina. El síndrome de Kawasaki, en cambio, se presenta con ojo rojo, labios rojos y partidos, lengua roja, edema de manos y pies, y adenopatía cervical. Requiere ecocardiograma para evaluar las arterias coronarias y tratamiento urgente con aspirina más inmunoglobulina G endovenosa. La mononucleosis infecciosa se caracteriza por el exudado blanco superficial adherente en las amígdalas, linfocitosis y, característicamente, aparición de rash morbiliforme tras administración de aminopenicilinas. Este fenómeno ocurre en hasta el treinta por ciento de los casos espontáneamente, pero asciende al noventa por ciento cuando se administra amoxicilina o ampicilina. Por esto, ante sospecha de mononucleosis se deben evitar las aminopenicilinas y el tratamiento es sintomático.